

■ 嚥下障害／経鼻胃管

経鼻胃管を抜くと咽頭残留と誤嚥が減る 喉頭侵入・誤嚥は37.7%→15.1%

神経原性嚥下障害53人、同一患者で留置下と抜去後のFEESを比較

抜去後は、喉頭蓋谷と梨状窩の残留がすべての形態で有意に減少した(p<0.001、効果量r=0.600～0.748)。PAS(喉頭侵入・誤嚥スケール)も改善した(p<0.001、r=0.468、95%CI 0.226～0.655)。侵入があった20人中12人(60%)で侵入が消え、抜

去後に新たに侵入が出た人はいなかった(p=0.0005)。年齢と結果に有意な関連はなかった。全員が留置→抜去の固定順で検査を受けたため、順序の影響を切り分けられず、著者らも因果は確定できないとしている。単施設・53人の規

模。NGT留置中の評価は嚥下能力を低く見積もる可能性があり、早めの再評価と適切な時期の抜去を検討する根拠の一つになる。



留置中の評価だけで、嚥下の力を決めつけない

出典 [Acta Oto-Laryngologica](#) ↗

数字で見る

53人 NGT15日以上留置の神経原性嚥下障害患者	37.7→15.1% 喉頭侵入・誤嚥の割合、留置下→抜去後	12/20人 侵入があった人のうち抜去後に消失した人数
------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

■ 脳卒中／上肢・疼痛

片麻痺肩痛、TENSとNMESの併用で TENS単独より痛みと肩の機能が改善

SPADIは併用群とNMES単独群の間に差がなく、上肢運動機能・痙縮・ADLへの上乘せ効果もなかった。電気刺激なしの対照群がなく、3週間の短期評価で脱落も15人ある。



出典 [Arch Phys Med Rehabil](#) ↗

■ 脳卒中／音楽療法

音楽を併用した脳卒中リハ、 21試験1029人の統合で6項目が改善

抄録に異質性やエビデンスの確実性(GRADE)の記載はなく、歩行速度は信頼区間が広い(0.16～1.62)。介入の種類や発症からの時期をまとめて統合しており、どの介入が誰に効くかまでは言えない。



出典 [Frontiers in Neurology](#) ↗

短信

〈嚥下リハビリ〉**頭頸部がんの嚥下リハ、決定打なし**
18試験1,139人のNMA。運動が通常ケアより臨床評価を改善(SMD0.98)、確実性は中～非常に低 出典 [Clin Rehabil](#) ↗

〈医療AI〉**大腿骨骨折の予後予測AI、40研究を検証**
死亡予測の識別能は中～高。外部検証と校正の報告が不十分で臨床導入は未熟 出典 [Curr Osteoporos Rep](#) ↗

〈脳卒中／歩行〉**歩けない亜急性期ほどロボット歩行訓練が有利か**
RCT36人の事後解析。FAC0-1でFAC2点改善90.0%対45.5%(15人)、探索的 出典 [Frontiers Rehabil Sci](#) ↗

〈転倒予防〉**高齢MSの転倒、自己申告の歩行尺度でも予測**
109人を平均2.2年追跡。PPDS1SDでOR1.28、SPPB1SDでOR0.75、両者は同等 出典 [Arch Phys Med Rehabil](#) ↗

〈心臓リハビリ〉**2型心筋梗塞は心リハ紹介が少ない**
臨床医110人。紹介頻度30%対1型80%。患者の82%は紹介されれば参加意向 出典 [JACC Adv](#) ↗

〈介護保険〉**利用料2割負担の対象拡大、議論が再開**
9月18日の介護保険部会。賛否両論が続き、年内の意見取りまとめを目指す 出典 [GemMed](#) ↗

〈高齢者と薬〉**高齢OABの抗コリン薬、認知障害と関連か**
NHANES横断研究。75～79歳で調整OR7.18。使用歴不明で因果は不明 出典 [Medical Tribune](#) ↗

〈働き方〉**PT・OT・STの燃え尽き、介入研究は3件のみ**
スコーピングレビュー30研究。燃え尽きは倫理的負担・業務量と関連 出典 [J Allied Health](#) ↗